

- 13★★★★
☑☑☑ High-resolution computed tomography (HRCT) 像では両側下葉、背側、胸膜直下に優位に分布する蜂巣肺と網状影が重要である。
- 14★★★★
☑☑☑ HRCT 像での蜂巣肺は IPF に特異的な所見である。
- 15★★★★
☑☑☑ HRCT 像で牽引性気管支拡張が認められる。
- 16★★★★
☑☑☑ 線維化性 NSIP との鑑別は容易である。
- 17★★★★
☑☑☑ 肺活量 (VC)、努力性肺活量 (FVC)、全肺気量 (TLC) の低下が認められる。
- 18★★★★
☑☑☑ VC や TLC が減少した後に拡散能 (DL_{CO}) が低下する。
- 19★★★★
☑☑☑ 重症例では安静時でも動脈血酸素分圧 (PaO_2) が低下し、肺泡気動脈血酸素分圧較差 ($A-aDO_2$) が開大する。
- 20★★★★
☑☑☑ 重症例では 6 分間歩行試験中の SpO_2 低下が著しい。
- 21★★★★
☑☑☑ 6分間歩行試験は歩行障害を有する患者でも正確な評価が可能である。
- 22★★★★
☑☑☑ 6分間歩行試験では心不全に伴う呼吸不全の要素は排除できない。
- 23★★★★
☑☑☑ 病勢の評価には定期的な FVC 測定が有用である。
- 24★★★★
☑☑☑ 厚生労働省の難病に指定されている。

